

INDICADO POR: Drº Zampa

X ACOMPANHAMENTO X CONSULTA

NS

Rozely Hilda Teixeira Santos

IDADE: 71 PESO: 65 ALTURA: 159 PROFISSÃO: Professora - Apos.

SINTOMAS: cansaço indisposta / mmII (+ perna D)

QUEIXAS: Parada resp. da família Dormir em DL E

MEDICAMENTOS: Diavam / Monocordil / Lipitor / Ezetrol / Zyloric / AAS /
Hipotireoide / Aldactone / Symtrazole / Zolozok / Larix

MÉDICO: Drº Genivaldo / Drº Zampa

MARCAPASSO: X S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N Há 1 ano.

EXERCÍCIO FÍSICO: Caminha (5x semana)

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 5 (20:30)

HORA QUE DORME: 23 HORA QUE ACORDA: 5:30

COCHILHO () S X N DORME ACOMPANHADO: X S () N () EVENTUALMENTE (resaca)
(ou vezes)

TEM FILHOS: X S () N / DORMEM NO QUARTO: () S X N PET NO QUARTO: () S X N

BEBIDA ALCOÓLICA: (X) S () X NA SEMANA () N - ou vezes

FUMO: () S () MAÇO/DIA X NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: mista BANHEIRO/NOITE: 2x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: MALLAMPATI: IAH: 74.5 SPO2: 80%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Cirurgia de colocação de stent na aorta
e marcapasso. microdisp. 28,9 e per

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA Arritmia 58-75 bpm.

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (G) ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS: esquecidos

POLISSONOGRAMA COM CPAP: X S () N SPO2 C/ CPAP: 87% PRESSÃO NO EXAME: 6

08/07 Avaliação

25
15/07 Dormir bem. ↓ volume S/ alterações de adapt.
25 P=6 / IAH= 2.2 / m. de uso: 8m.22/07 P=6 melhor
25 IAH= 1.5 e 1.7 (ajuste máscara
melhora cansaço / melhora
dox. polêmica) e no x banheiro
fuga claudica
Fuga = 3.4 lpm.

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Rosely Hilda Teixeira Santos
EXAME nº: 5600
SOLICITADO POR: Dr. Antonio Carlos Zampa
DATA: 19/04/2024
IDADE: 70 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h03min e concluído às 06h05min. A latência para o sono foi de 7 minutos e a latência para o estágio REM, de 263 minutos. O tempo total de sono foi de 378,5 minutos (06h18min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 90,6%. A distribuição do sono mostrou 21,4% de estágio 1, 59,6% de estágio 2, 5,4% de estágio 3 e 13,6% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 32 minutos em vigília, ocorreram 182 microdespertares (índice: 28,9/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 74,5/hora, sendo 37,1 apneia/hora e 37,4 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 74,5/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 93%, sendo a média de 90% e a mínima de 80%.

(*) TTS ⇨ Tempo Total de Sono TTR ⇨ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (74,5/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (74,5/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e episódios de arritmia cardíaca. As frequências cardíacas foram: mínima: 58; máxima: 75 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 7 min; normal até 30 min). A latência para o sono REM estava alongada (263 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono (90,6%; normal: 85% ou acima) permanecer no limite da normalidade, o sono foi fragmentado microdespertares (índice: 28,9/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (21,4%; normal: 8-10%) e 2 (59,6%; normal: 45-55%), e a redução dos estágios 3 (5,4%; normal: 10-12%) e REM (13,6%; normal: 20%).

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 4 (normal até 9; máxima: 24).